Bảng 5. Đối tượng đạt mức độ kháng thể định trước đối với kháng nguyên vắc xin dùng đồng thời (trong Nghiên cứu 6096A1-004, Nghiên cứu 6096A1-3005 và Nghiên cứu 6096A1-3008)		
Tên vắc xin/kháng nguyên trong vắc xin (Mức độ kháng thể định trước)	**% người đáp ứng trong nhóm Prevenar 13 (n^a/N^b)**	**% người đáp ứng trong nhóm vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn (n^a/N^b)**
Đáp ứng PedvaxHIB (PRP-OMP) từ 12 đến 15 tháng sau đợt tiêm chủng ActHIB dành cho trẻ sơ sinh		
Hib (PRP) (≥ 0,15 µg/ml)	100,0 (230/230)	100,0 (214/214)
Hib (PRP) (≥ 1,0 µg/ml)	90,4 (208/230)	92,1 (197/214)
Đáp ứng ProQuad (MMR-thủy đậu) từ 12 đến 15 tháng		
Sởi (≥ 1,10 qua tĩnh mạch)	96,4 (213/221)	97,1 (204/210)
Quai bị (≥ 1,10 qua tĩnh mạch)	76,5 (169/221)	72,9 (153/210)
Rubella (sởi Đức) (≥ 15 đơn vị quốc tế/ml)	91,9 (192/209)	90,7 (185/204)
Thủy đậu (≥ 1,09 qua tĩnh mạch)	26,7 (59/221)	21,9 (46/210)
[a] Số đối tượng đạt mức độ kháng thể định trước. [b] Số đối tượng trong quần thể có tính sinh miễn dịch đánh giá được.		

Trẻ em và thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi

Trong Nghiên cứu 6096A1-3011 tại Mỹ, ở trẻ em từ 5 đến <10 tuổi trước đó được tiêm chủng tối thiểu một liều vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn, và ở trẻ em và thiếu niên chưa tiêm chủng vắc xin phế cầu khuẩn từ 10 đến 17 tuổi, 1 liều Prevenar 13 đã kích thích đáp ứng miễn dịch với cả 13 týp huyết thanh.

Ở trẻ em từ 5 đến <10 tuổi, nồng độ IgG trong huyết thanh cho 7 týp huyết thanh thường gặp 1 tháng sau khi cho dùng một liều đơn Prevenar 13 (Nghiên cứu 6096A1-3011) không kém hơn (ví dụ, giới hạn dưới của khoảng tin cậy 95% 2 bên cho tỷ lệ trung bình nhân [GMR] là >0,5) so với nồng độ sinh ra bởi liều cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn thứ tư ở lúc từ 12 đến 15 tháng tuổi (Nghiên cứu 6096A1-3005). Ngoài ra, nồng độ IgG sinh ra bởi một liều đơn Prevenar 13 đối với 6 týp huyết thanh bổ sung ở trẻ em từ 5 đến <10 tuổi không kém hơn so với nồng độ sinh ra bởi liều Prevenar 13 thứ tư ở lúc từ 12 đến 15 tháng tuổi (Nghiên cứu 6096A1-3005) như thể hiện trong Bảng 6 và 7.